

담낭 폴립, 어떻게 추적할까요?

핵심은 크기 · 모양 · 담낭벽 · 성장 변화입니다.

광교바른내과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE

담낭 폴립 안내

대부분은 양성이지만, 기준에 맞춰 놓치지 않고 관찰합니다.

1 처음 발견되면 확인할 4가지

검진 초음파에서 담낭 폴립이 보이면 아래 4가지를 기록해 두면 추적 판단이 쉬워집니다.

① 크기(mm)

가장 긴 지름. 1cm는 10mm입니다.

② 모양

자루형인지, 벽에 넓게 붙었는지 봅니다.

③ 담낭벽

두꺼워짐·불규칙이 있으면 더 주의합니다.

④ 변화

이전보다 커졌거나 모양이 달라졌는지 비교합니다.

자루형

자루가 있는 폴립
상대적으로 안심되는 모양이
많지만, 크기 변화는
확인합니다.



넓은 부착형

넓게 붙은 폴립
성장·담낭벽 변화를 더
주의해서 봅니다.



2 왜 초음파로 추적하나요?

담낭 폴립의 1차 평가는 **복부초음파**입니다. CT/MRI가 작은 폴립을 항상 더 잘 보는 것은 아니며, 암이 의심되거나 초음파가 불충분할 때 선택적으로 고려합니다.

방사선 없음

반복 비교 쉬움

작은 변화 관찰

3 수술 상담이 필요한 신호

- 15mm 이상이거나, 10-14mm에 의심 소견이 동반될 때
- 추적 중 분명히 커져 10mm 또는 15mm 경계를 넘을 때
- 넓은 바닥형, 담낭벽 두꺼워짐·불규칙이 보일 때
- 다른 원인을 배제해도 담낭 관련 증상이 지속될 때
- PSC, CA 19-9 상승, 영상에서 암 의심 시에는 개별 전문 진료

4 크기와 의심 소견에 따른 추적 방향

아래는 일반 원칙입니다. 실제 간격은 영상 소견·나이·위험인자를 보고 진료실에서 정합니다.

< 6mm

관찰

의심 소견 없음

대개 정기 추적이 꼭 필요하지 않거나 제한적으로 추적합니다.

6-9mm

선택 추적

의심 소견 없음

위험인자와 결과지에 따라 추적 여부·간격을 개별 결정합니다.

6-9mm

밀착 추적

의심 소견 또는 50세 이상

가까운 간격의 초음파 추적 또는 수술 상담을 논의합니다.

10-14mm

개별 상담

의심 소견 없음

수술과 초음파 추적 중 어느 쪽이 적절한지 상담합니다.

10-14mm

수술 고려

의심 소견 있음

몸 상태가 가능하다면 담낭절제술을 적극 고려합니다.

≥ 15mm

수술 권고

크기 자체로 해당

수술 가능 상태라면 담낭절제술을 일반적으로 권고합니다.

* 의심 소견 = 넓은 바닥형(sessile), 담낭벽 두꺼워짐·불규칙, 추적 중 명확한 성장, 환자 위험인자 등을 종합합니다. 일부 가이드라인의 6개월·1년·2년 추적은 선택군 기준이며 모든 환자에게 일률 적용되는 규칙은 아닙니다.

5 검사 전후 체크

☑ 6시간 금식 후 검사하면 담낭이 잘 퍼져 더 정확합니다.

☑ 가능하면 같은 병원에서 비교하거나 이전 결과지를 가져오세요.

☑ 결과지의 크기·모양·담낭벽·추적 권고를 확인하세요.

☑ 통증은 폴립만으로 단정하지 않고 담석·위장질환도 함께 봅니다.

안내 · 본 자료의 한계

본 자료는 환자 안내용 참고자료입니다. 초음파만으로 양성·악성을 100% 구분할 수 없으며, PSC, CA 19-9 상승, 암 의심 영상, 초음파가 불충분한 경우는 개별 진료가 필요합니다. 최종 방침은 담당 의사와 상담해 정합니다.

근거: KSAR Korean J Radiol. 2025;26:102-134 · Foley KG 외 Eur Radiol. 2022;32:3358-3368 · Knight J 외 Abdom Radiol. 2024;49:3158-3165

